

PICADURAS DE INSECTOS Y ARÁCNIDOS

INTRODUCCIÓN

Ambos animales son invertebrados y pertenecen al grupo de artrópodos, pero dentro de este se dividen en insectos y arácnidos por las diferencias que existen entre ellos. Las arañas se diferencian de los insectos por el número de patas, la forma del cuerpo y porque no tienen alas, entre otros detalles.

Los escorpiones pertenecen a la familia de los arácnidos, que también abarca a los ácaros, las garrapatas y las arañas.

Las manifestaciones clínicas por picaduras de mosquitos, jejenes, moscas, garrapatas, piojos, arañas, escorpiones, pulgas, chinches, ácaros, escarabajos y orugas son motivo frecuente de consulta y pueden confundirse con los signos de otras patologías. El término “picadura”, engloba a todos los accidentes por insectos.

Los coleópteros (escarabajos, gorgojos, mariquitas) no pican, causan lesiones cuando evacúan una sustancia irritante (*caga-fogo*, resumen los brasileños).

Para este capítulo se han seleccionado los siguientes temas.

- Accidentes por escorpiones, arañas y abejas, porque los tres pueden causar síntomas graves, incluso la muerte.
- Edema de párpado por mosquitos o jejenes, por ser una consulta frecuente que muchas veces se confunde con celulitis bacterianas.
- Miasis tumoral, por el desafío diagnóstico para quienes no vivimos en la provincia de Misiones. Un viajero puede acudir con esta patología a cualquier consultorio del país.
- Dermatitis por coleópteros, porque son frecuentes en el litoral y se las confunde con: piodermitis, celulitis e infecciones por herpes.

Para acotar el tema, se han dejado de lado a pulgas, piojos, chinches, garrapatas, orugas; también a las grandes enfermedades donde el insecto es vector de un agente infeccioso. Por ejemplo: Dengue, Chagas, Paludismo, Leishmaniasis, Encefalitis equina.



Las imágenes, que ilustran la ubicación, forma y coloración de las lesiones, se presentan en soporte digital lo que permite una mejor definición e información. Se han ubicado en el campus virtual de SAP. Podrá acceder a las mismas escaneando el código QR.

- PRONAP- Material complementario – Picaduras de insectos y arácnidos.
- PRONAP – Material complementario – Dermatitis atópica y Psoriasis.

OBJETIVOS

- ◆ Identificar algunos de los insectos cuyas picaduras pueden dañar la salud de los niños en territorio argentino.
- ◆ Promover medidas de prevención de picaduras y/o accidentes con insectos.
- ◆ Establecer el diagnóstico diferencial entre la dermatitis por accidente con coleópteros y la piodermitis, la celulitis y las infecciones por herpes.
- ◆ Reconocer signos y síntomas e indicar tratamientos en casos de picaduras de escorpiones, arañas y abejas.
- ◆ Resolver consultas por prurigo infantil.
- ◆ Resolver consultas por miasis cutánea forunculosa.

PICADURAS DE INSECTOS

“Fede despertó con un ojo totalmente cerrado”

En una mañana de diciembre de 2022, Federico de 3 años, despertó con edema bi palpebral (ver figura 1), que le impedía abrir el ojo derecho. No tenía secreciones, dolor ni fiebre. Durante el atardecer del día anterior había ido a jugar a la plaza.

¿Cuál es la presunción diagnóstica? Prurigo agudo por picadura de insectos, lo más probable mosquitos o jejenes, que lo picaron en la plaza o durante el sueño.

Durante 36 horas el edema fue en aumento. El niño conservó buen estado general, sin fiebre, ni dolor. Sólo algo de prurito. Se indicó compresa fría local y antihistamínico oral. No es necesario medicar con corticoides ni antibióticos.

El diagnóstico diferencial debe hacerse con las infecciones bacterianas. En la celulitis pre septal, suele haber una escoriación, párpados hinchados, calientes, enrojecidos y dolorosos. En la celulitis orbitaria: tejidos abultados, quemosis, dificultad para mover el globo ocular. Acompañadas de fiebre, dolor y mal estado general.

¿Cómo se previenen las picaduras de insectos? Los repelentes de insectos con DEET (Dietil toluamida) se indican desde los 2 meses de edad. En menores de 2 meses: mosquiteros. La protección de la crema y el spray con DEET al 10% es de hasta 2 horas. Los repelentes con citronela son poco eficaces.

Recuerdos de Misiones

En febrero de 2011, Verónica de 15 años, consultó por una supuración dolorosa en flanco izquierdo (Figura 2), de tres semanas de evolución. Durante sus vacaciones en la primera quincena de enero, la adolescente conoció los Saltos del Moconá.

¿Cuál es el diagnóstico más probable? La miasis cutánea forunculosa (“ura”), es una tumoración dolorosa, con orificio externo delimitado. La mosca *Dermatobia hominis* (Figuras 1 y 2) deposita sus huevos en un mosquito que al picar facilita que los huevos queden en la piel, pasen a larva y penetren.

¿Qué hacer: indicar antibióticos o drenar?

En Paraguay, con ivermectina oral han logrado resultados positivos en un 80% de los casos. Las larvas se eliminan a través de una incisión cruciforme. En Verónica, se extrajo una larva de mosca. La larva era grisácea con tres hileras transversales de ganchos en el cuerpo y un poro en un extremo, para respirar una vez que penetra la dermis (Figuras 3 - 4 y 5).

“Dermatitis por las noches de verano”

Durante los meses cálidos y húmedos, en Santa Fe, consultan niños con lesiones eritematosas en distintas partes de la piel expuesta (cuello, brazos, tronco y cara). Algunos de los casos tienen vesículas, pseudo pústulas y máculas crateriformes. (Figuras 6, 7 y 8 y 9). Los pacientes conservan buen estado y no tienen fiebre. Muchos niños reciben, de manera innecesaria, antibióticos, corticoides y hasta aciclovir.

¿Cuál es el diagnóstico más probable? Dermatitis por contacto con *Paederus*. En las noches calurosas, la luz artificial atrae a pequeños coleópteros. Uno de ellos, el *Paederus* sp, de 10 mm, tiene vesículas anales que eliminan un líquido urticante (Figura 10). Las lesiones dérmicas aparecen 18 a 24 horas después del contacto. Pasada una semana, se forman costras que luego, entre 3 a 4 semanas, desaparecen (Figura 11).

¿Cuáles son las indicaciones? Lavar la piel con agua y jabón. Si ya hay lesiones, colocar paños con agua de avena o crema con hidrocortisona. Para calmar el prurito, indicar cetirizina, hidroxici- na o difenhidramina. No se necesitan corticoides sistémicos.

“¡Recién a Mari la picaron abejas y ella se descompuso!”

En Santa Fe, durante una mañana de febrero de 2014, María de 6 años, tras ser picada por abejas, se puso hipotónica y muy pálida. La madre la alzó y llevó rápido hasta el centro de salud del barrio Santa Rosa de Lima. La niña presentaba edema en párpados, labios y manos.

María tenía síntomas de reacción alérgica generalizada. Las médicas residentes de pediatría le inyectaron adrenalina, colocaron máscara de oxígeno y gotearon suero fisiológico por vena. Luego, la niña fue controlada en el hospital. Egresó 6 horas después, en buen estado y con una cita programada con el especialista en alergia.

¿Cómo actuar frente a picaduras de abejas cuando hay anafilaxia? Las picaduras de himenópteros pueden matar por envenenamientos masivos (enjambre de abejas) o por anafilaxia a los componentes alergénicos del veneno.

La reacción de anafilaxia se manifiesta con alguno de estos síntomas: eritema, urticaria generalizada, angioedema, tos, obstrucción bronquial, dolor torácico, náuseas, vómitos, diarrea, mareos, desvanecimiento, hipotensión arterial, arritmia cardíaca y paro.

Tratamiento. Adrenalina 0,01ml/kg; dosis 0,1 ml c/10 kg de peso, dosis máxima 0,5 ml. Intramuscular, en cara lateral del muslo. Además indicar oxígeno y expansión con solución fisiológica. Una opción para administrar adrenalina es el auto inyector de 0,15 mg (< de 30 kg) o 0,3 mg (> de 30 kg). Se inyecta en el muslo, con un golpe seco y recto.

Para prevenir anafilaxia por picaduras de himenópteros, la inmunoterapia con veneno realizada por el especialista es un método seguro y eficaz.

Si queda el aguijón clavado, para evitar la inyección adicional del veneno, no hay que comprimir. Sí “tarjetear”, en dirección contraria al ingreso (Figura 12).

En la primavera de 2017, en un campo de La Pampa, un niño de 9 años fue picado por abejas; grave, fue llevado hasta el hospital de la capital provincial, donde falleció.

En una serie de casos de anafilaxia, todos los que recibieron adrenalina dentro de los **primeros 5 minutos**, sobrevivieron. **No hay contraindicación para administrar adrenalina a un niño. La adrenalina es esencial.** Antihistamínicos y corticoides sólo complementan el tratamiento. Difenhidramina 1 mg/kg Hidrocortisona EV o IM (10 mg/kg/día).

ACCIDENTES POR ESCORPIONES Y ARAÑAS

“¿Es peligroso?”

Pregunta la mamá de un niño de cuatro años que encontró un escorpión en el baño de la casa. (Figura 13).

El escorpión o alacrán (*Tityus sp.*) puede causar desde enfermedad leve a grave, incluso la muerte. Es de color marrón claro, con tres bandas longitudinales más oscuras, pinzas largas y finas y en el último segmento de la cola tiene dos picos: el más largo y curvo es la púa con la que inyecta el veneno.

El escorpión no venenoso (*Bothriurus sp.*) posee el dorso negro, las pinzas cortas y gruesas y su cola termina en un solo pico, el del aguijón. Al escorpión venenoso se lo encuentra en las provincias del centro y norte de Argentina. Tiene hábitos nocturnos e ingresa los hogares a través de las puertas, desagües y tuberías de la luz. Los escorpiones no son agresivos, atacan sólo para defenderse. La mayoría de los casos de escorpionismo (cuadro clínico generado por la inoculación del veneno de escorpiones) acontecen durante los meses más cálidos. Pero aún en invierno ocurren accidentes graves.

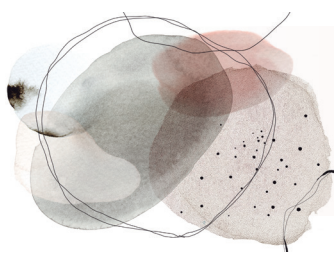
Entre el año 2000 y el 2023, en el Hospital de Niños Dr. O. Alassia, de Santa Fe, 5.186 casos consultaron por picadura de escorpión. Alrededor del 85% fueron leves y el 15% fueron entre moderados a graves; ocho menores de 10 años fallecieron.

En Argentina se notifican en promedio 8.000 casos anuales y con una mortalidad que oscila en 2 y 8 víctimas por año.

¿Cómo suceden las picaduras por escorpión? La mayoría de los accidentes ocurren en los domicilios. Los sitios del cuerpo aguijoneados con más frecuencia son los pies (el escorpión se refugia en el calzado) y el tronco (el alacrán se esconde entre las sábanas). Otros lugares: manos, brazos, piernas. Las picaduras en la cabeza son raras y peligrosas.

¿Cuáles son los síntomas? El emponzoñamiento causa dolor inmediato y desgarrador. El niño llora de manera inconsolable. En el sitio de la picadura no se suelen encontrar marcas ni reacciones locales. En la mayoría de los casos la picadura sólo causa dolor, pero en alrededor del 15% de los afectados, pueden agregarse manifestaciones sistémicas que aparecen a pocos minutos del emponzoñamiento y hasta dos horas después. El veneno inyectado estimula las glándulas suprarrenales y los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, liberando rápidamente acetilcolina, adrenalina y noradrenalina, mediadores que impactarán en todo el organismo.

En el escorpionismo sistémico, los síntomas suelen comenzar con un estímulo parasimpático transitorio. El niño tiene: vómitos; sialorrea, rinorrea; lagrimeo, sudoración; piel pálida con piloerección. Pueden sumarse miosis, bradicardia, hipotensión arterial, dolor abdominal, diarrea, temblores, hipo o hipertermia. Enseguida, la descarga adrenérgica se hace notoria con midriasis, taquicardia, hipertensión arterial. En los cuadros graves, la persistencia de altas concentraciones de catecolaminas produce arritmias cardíacas, edema pulmonar agudo, insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico.



Si un niño sano grita de dolor al calzarlo, al acostarlo o al vestirlo, se debe sospechar escorpionismo, se encuentre o no al ejemplar.

Los vómitos reiterados son un signo premonitorio de gravedad. El niño debe ser derivado a un hospital que cuente con cuidados intensivos.

¿Cómo tratar una picadura por escorpión en los menores de 12 años? Cuando sólo hay dolor (escorpionismo leve): colocar hielo en la región y observar al paciente durante 4 horas. Si se agregan vómitos repetidos (escorpionismo moderado-grave) **medicar con suero antiescorpiónico** (SAE), del INPB A.N.L.I.S. Dr. Carlos G. Malbrán. La unidad tiene 2ml. Lo ideal es administrar el SAE vía endovenosa, en bolo, antes que pasen 2 horas de la picadura. En casos moderados, 2 a 4 unidades; en los graves: 4 a 6 unidades.

Para solicitar el SAE ver listado en

<https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-10/04-2011-guia-evenenamiento-escorpiones.pdf>

¿Cuáles son las complicaciones del escorpionismo grave? El edema agudo de pulmón junto al bajo gasto cardíaco son los problemas más frecuentes. La unidad de terapia intensiva debe estar alerta para resolver otras complicaciones como arritmias, hipotensión arterial y shock cardiogénico. La mayoría de los pacientes graves requieren de soporte hemodinámico y ventilación mecánica invasiva.

¿Qué exámenes complementarios se deben solicitar en un caso de escorpionismo grave?

- **Laboratorio.** La andanada adrenérgica causa hiperglucemia, leucocitosis, hipopotasemia; también acidosis metabólica con anión gap aumentado y, ocasionalmente, elevación de amilasa y de CPK-MB (cuando ya hay daño miocárdico).
- **ECG.** Para documentar taquicardia o bradicardia sinusal, extrasístoles supraventriculares o ventriculares, aplanamiento o inversión de la onda T, en derivaciones múltiples; depresión del segmento ST, bloqueo auriculoventricular o intraventricular. En los pacientes que se recuperan, lo esperable es que las alteraciones electrocardiográficas desaparezcan antes de la primera semana.
- **Ecocardiograma.** Para ver disfunción sistólica de grado variable del ventrículo izquierdo con disminución de la fracción de eyección y dilatación cardíaca.
- **Rx de tórax.** Puede mostrar cardiomegalia y signos de edema pulmonar agudo.

¿Cómo prevenir las picaduras por escorpión? ¡Sacuda! es la palabra clave.

Sacudir las zapatillas antes de calzar al niño; la ropa antes de vestirlo y las sábanas, antes de acostarlo. También, previo a usar un trapo de piso, hay que agitarlo.

Barreras. En las puertas, colocar burletes y en los desagües, filtros embudos (se consiguen en ferreterías). Insecticidas. Cuando el piretroide bifentrina está en contacto directo con el cuerpo de escorpiones los mata en 5 días. Sin embargo, tanto este como otros pesticidas, son poco efectivos. Carecen de efecto residual y es improbable que los escorpiones sean alcanzados en sus refugios. Además, emplear insecticidas en el interior de los hogares, puede ser riesgoso para los menores. Video: <https://www.youtube.com/watch?v=TLZKPCdD6XA&t=25s>

“Consulta por WhatsApp. 20/12/20 “18.23 horas”. Manu (1 año 8 meses)”

A Manu lo picó una araña, hace minutos. Lo picó esta araña (Figura 14) Jugábamos en el piso y de repente lloró con fuerza, al levantarlo vimos salir a esa araña del lugar dónde él estaba. Le apareció esta roncha. (Figura 15) Ahora juega. ¿Lo llevamos a una guardia? Esta familia habita en un pequeño pueblo de la provincia.

La araña que picó a Manu era una *Cybaeodamus meridionalis*. Se la encuentra en el noroeste y el litoral argentino. Su picadura causa reacción local leve.

¿Qué aconsejar ante la consulta de picadura de araña? No es necesario identificar los miles de especies de arañas. Basta con saber que la del caso, no es ninguna de las tres que tienen importancia sanitaria en Argentina: “la de los rincones”; “la viuda negra” y “la del banano”.

Araña del rincón (*Loxosceles*). Su cuerpo mide 1 cm, tiene forma de violín y es de color gris o marrón (Figura 16). Se la encuentra en viviendas de todo el país; detrás de cuadros, cielorrasos, muebles, ropas, etc. No es agresiva, sólo pica cuando es apretada. Su veneno da necrosis local y en 10% de los casos, hemólisis sistémica. El momento de la picadura puede pasar inadvertido, más tarde aparecen dolor progresivo, edema local y una pápula que evoluciona de placa roja a marmórea.

Entre el quinto y séptimo día se forma una escara que al caer deja una úlcera.

El loxoscelismo sistémico se manifiesta en las primeras 48 horas con anemia hemolítica, ictericia y hemoglobinuria. Puede progresar hacia coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda y muerte.

Tratamiento. Analgesia y antiveneno (Butantan) que resulta eficaz dentro de las 36 horas del accidente. Por vena, dosis para la forma cutánea: 5 ampollas y dosis para la forma cutáneo-sistémica: 10 ampollas.

Durante la primavera de 2022, en la provincia de Buenos Aires, murieron por el veneno de la araña del rincón, (Figura 16), un hombre de 52 años picado en la mano y una niña de 18 meses, picada en el mentón.

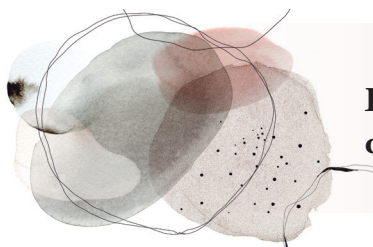
Viuda negra (*Lactrodectus*). Las hembras miden entre 1,5 hasta 3 cm, son negras con una mancha rojiza en el abdomen. Se las encuentra en zonas rurales de Argentina; sobre todo en Santiago del Estero, Córdoba y provincias cordilleranas. Estas arañas habitan cerca del suelo, entre gramíneas, arbustos y escombros. Los accidentes suceden durante los meses cálidos. Solo agreden para defenderse con su veneno neurotóxico, que puede llegar a matar. En el sitio de la picadura, el accidentado, siente un pinchazo que deja eritema y pápula pequeña. (Figura 17). A partir de allí, 15 a 60 minutos después, hay espasmos musculares que se irradian a todo el cuerpo. La víctima tiene cefalea, disnea, hipertensión, sudoración y cara rubicunda.

Raúl 12 años

En febrero de 2010, en Ceres (Santa Fe), al acostarse sobre rastrojos de sorgo, fue picado en el hombro izquierdo por una araña negra con mancha roja. (Figura 18).

A los 30 minutos Raúl se quejó de intenso dolor abdominal que se extendió a la zona lumbar. Consultó, sudoroso, con taquicardia y somnolencia. En el hospital local, recibió 2 ampollas de suero anti lactrodectus y fue derivado. Cuando ingresó al Hospital de Niños Alassia, los síntomas estaban atenuados. A las 24 horas. Raúl se recuperó.

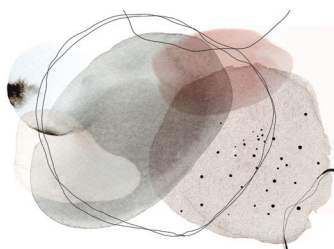
Araña del banano (*Phoneutria*). El cuerpo de esta araña puede medir más de 4 cm. y está cubierto por pelos castaño oscuro. (Figura 20). Se la encuentra en Misiones, Formosa y las yungas de Jujuy y Salta.



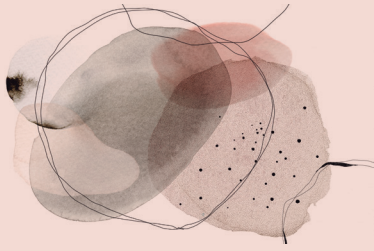
En la mayoría de los accidentes sólo hay dolor local, pero en ocasiones el cuadro avanza hacia síntomas graves.

Antiveneno: *Soro Antiaracnídico polivalente* (Butantan, Brasil). Casos leves: 2 a 4 ampollas. Graves: 5 a 10 ampollas. Guía disponible en:

<https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-de-prevencion-diagnostico-tratamiento-y-vigilancia-epidemiologica-del-envenenamiento-0>



Telas de araña. Las de especies no peligrosas, son regulares, organizadas y simétricas. Las de especies venenosas son irregulares, algodonosas y compactas.



Autoevaluación

I. Establezca la correspondencia.

Establezca la correspondencia entre los insectos y arácnidos que figuran en la columna de la izquierda y los enunciados de la columna de la derecha. Coloque la letra que corresponda en cada insecto. Cada letra puede ser usada una, varias o ninguna vez.

Escorpión	a) El emponzoñamiento causa dolor inmediato. b) El momento de la picadura puede pasar inadvertido. c) Su picadura puede matar por envenenamiento masivo y/o por anafilaxia a los componentes del veneno. d) El veneno inyectado estimula las glándulas suprarrenales y los sistemas simpático y parasimpático liberando acetilcolina, adrenalina y noradrenalina.	
Arañas	e) Ataca cuando se siente amenazada. f) Los vómitos reiterados son signo premonitorio de gravedad. g) Manifestaciones sistémicas pueden aparecer a los pocos minutos después de la picadura y hasta 2 horas más tarde. h) Su veneno puede llegar a matar.	Del rincón Viuda negra Del banano
Abejas	i) Administrar SAE via endovenosa antes que pasen 2 horas del accidente. j) El antiveneno (butantan) resulta eficaz dentro de las 36 horas de producido el accidente. k) Administrar adrenalina intramuscular. l) Administrar suero anti-lactrodectus.	

Compare sus respuestas con las que figuran en la CLAVE DE RESPUESTAS.